

كتابة الوصفة الطبية وطرق اعطاء الدواء



مدرس المقرر: أ. أحمد السمرة

تعريف الدواء :

هو كل مادة تعطى بهدف العلاج أو الشفاء أو تخفيف المرض أو تشخيصه أو الوقاية منه

اسماء الادوية :

لكل دواء اربعة اسماء

١- اسم عام : هو الاسم الذي يطلق على الدواء قبل ان يكون له اسما رسميا

٢- اسم علمي : هو الاسم الذي يطلق على الدواء ويكون مكتوب ضمن البروشورات العالمية ويكون متعارف عليه ضمن المراجع الدوائية العالمية

٣- اسم الكيميائي : هو السم الذي يكون متعارف بين الكيميائيين ويصف الصيغة الكيميائية للدواء

٤- اسم تجاري : هو الاسم الذي تطلقه الشركة المصنعة على الدواء

الوصفة طبية (RX):

هي وثيقة رسمية في الرعاية الصحية التي يحررها الطبيب في شكل تعليمات التي تحكم خطة رعاية المريض. قد تشمل الوصفات الطبية أوامر يجب أن يقوم بها المريض، أو توجيهات إلى الممرضة أو الصيدلي أو الطبيب المعالج الآخر.

❖ ما هي اجزاء الوصفة الطبية ؟

- اسم الطبيب واختصاصه.
- اسم المريض وعمره وتشخيص مرضه ومسكنه.
- RX (دلالة استخدام الدواء)
- اسم الدواء (صاد حيوي أو أي نوع من الأدوية الأخرى).
- تركيز الدواء (٢٥٠ ملغ / ١٠٠٠ ملغ / ٠,٥ ميكروغرام / ١,٥ مليون وحدة دولية)
- الشكل الصيدلاني (أمبول / فيال/ حبوب/ شراب).
- N عدد الكبسولات الموصوفة (الكورس العلاجي الواجب إعطاءه).
- جرعة الدواء/ تكرار جرعات الدواء.
- طريقة إعطاء الدواء (عضلياً / فموياً / وريدياً/....).
- اسم الطبيب وختمه

❖ طرق إعطاء الدواء :

- ✓ فموي
- ✓ موضعي
- ✓ شرجي
- ✓ حقن

اسم الطبيب واختصاصه	
اسم المريض – عمره – جنسه – التشخيص الطبي	
RX)	
1)- Diclofinac NA	<u>amp</u> 75 mg
1*2*5 IM	
اسم الطبيب وتوقيعه او ختمه	

١. إعطاء الدواء فمويًا:
 - الشراب إما معلق فموي أو محلول.
 - الحب إما حب مضغوطة أو حب محفظة.
 - النقط الفموية.
 - الفوار.
٢. إعطاء الدواء حقنًا:
 - أمبول / فيال / فلاكون.
٣. إعطاء الدواء شرجيًا:
 - تحاميل/ حقن شرجية.
٤. إعطاء الدواء موضعياً:
 - كريم/ مرهم/ جل/ زيت/ غسولات / لصاقة/ بودرة/ قطرة/ بخاخ/ تحاميل.
٥. طريق الشدقي/ وتحت اللسان.

اختصارات لكل شكل من الأشكال الصيدلانية:
أولاً: فمويًا:

الفوار eff	الشراب محلول syr
الشراب معلق فموي susp	حب محفظة Cap
حب مضغوطة Tap	نقط فموية oral drop/ dp

ثانيًا: حقنًا:

فيال vial	أمبول amp	فلاكون Flacon
-----------	-----------	---------------

ثالثًا: شرجيًا:

تحاميل supp	حقن شرجية enema
-------------	-----------------

رابعًا: موضعيًا:

كريم cream	مرهم oint	جل gel
زيت oil	غسولات solation	لصاقة patch
بودرة powder	بخاخ spray	تحاميل مهبلية supp vagina
قطرة عين drop eye	قطرة أذن drop ear	قطرة أنف drop nose

□ كيفية إعطاء الدواء:

- قبل إعطاء أي دواء يجب التأكد من الصلاحية الخمس:
- ١. اسم المريض الثلاثي الصحيح.
- ٢. اسم الدواء الصحيح.
- ٣. طريقة إعطاء الدواء الصحيحة.
- ٤. جرعة الدواء الصحيحة.
- ٥. الوقت و التكرار الصحيح.

ملاحظة: يضاف إليها :

- ١. تاريخ صلاحية الدواء.
- ٢. شكل الدواء وقوامه .

الأدوية الفموية (حبوب / شراب) oral medication

الاهداف : (purpose)

- ١- توفير طريقة آمنة لتقديم الدواء.
- ٢- لتوفير تعزيز عمل الأدوية مع أقل ما يمكن من عدم الراحة.
- ٣- للحصول على تأثيرات علاجية على الجسم.

الأدوات: (equipment)

- عربة الأدوية.- الأدوية الموصوفة
- كؤوس الأدوية.
- كؤوس الأدوية المعيارية (للقياس).
- مدقة و هاوون.
- مناديل ورقية.
- بطاقة (لائحة) الأدوية.
- قلم و ورقة.
- ملف المريض سجل المريض
- صينية صغيرة أو حوض كلوي (لتقديم الدواء).
- كاس من الماء.
- إبريق من الماء.

الإجراء:

م	الخطوات	التبرير	S تم	U لم يتم
١	التأكد من تعليمات الطبيب من ملف المريض ومقارنتها مع سجل الأدوية	للتأكد من أن الدواء سوف يعطى بأمان و بدقة		
٢	تحضير بطاقة الأدوية			
٣	غسل اليدين	لمنع انتقال العدوى		
٤	قيّم قدرة المريض على البلع	للتأكد من إمكانية تناول المريض للدواء		
٥	تحضير الأدوات	ترتيب مكان العمل يوفر الوقت و يقلل الخطأ		
٦- ١	تحضير الحبوب الفموية			
a	اختيار الأدوية الصحيحة من علبة الأدوية (في البداية اقرأ اللاصقة) و قارنها مع سجل الأدوية، و تحقق من: (الصباح الخمس) ١- الدواء الصحيح ٢- اسم المريض ٣- طريق الإعطاء ٤- الجرعة والتكرار ٥- الوقت	فحص و تدقيق اللاصقة للأدوية الموصوفة يقلل الخطأ		
b	تأكد من (تاريخ انتهاء الصلاحية و أي تغير في اللون ، التناسق) للأدوية	للامان ، فساد أو انتهاء مفعول الدواء يمكن أن يكون أقل فعالية و يسبب الضرر.		
c	احسب الجرعة المطلوبة	لضمان سلامة المريض وإعطاء الجرعة بشكل صحيح		

d	وضع الحبوب الفموية و الكبسول في كؤوس الأدوية (اقرأ اللاصقة مرة ثانية)	لحفظ النظافة للدواء وللتأكد من أن المطلوب من الحبوب تم وضعه في كؤوس الأدوية		
e	طحن الحبوب الفموية بالمدقة و الهاون إذا كان المريض غير قادر على البلع			
٦-٢	تحضير الشراب الفموي			
	١- أزل الغطاء و ضعه على العربة الجزء العلوي للأسفل. ٢- امسك الزجاجاة بحيث تكون اللاصقة باتجاهك بينما تسكب (اقرأ للاصقة مرة ثانية). ٣- امسك كاس الدواء عند مستوى العين و أملا حتى المستوى المطلوب من الجرعة. ٤- بعد السكب امسح الحافة العلوية للزجاجاة بمنديل ورقية، بدون ملامسة الداخل.(اقرأ الاصقة مرة ثالثة)	١-لمنع تلوث الغطاء ٢-لمنع تلطخ أو إفساد اللاصقة عند السكب. ٣-يسمح بقياس دقيق و يمنع تلوث للدواء في القارورة ٤-تضمن انسداد أكيد و مناسب ، تمنع التسريب إلى اللاصقة.		
٧	اخذ صينية الدواء ووضعه الى جانب المريض			
٨	١-تحديد المريض الصحيح من خلال الشريط الموجود على معصم المريض ٢-التحقق من الرقم الطبي ٣- اطلب من المريض ان يقول اسمه ٤- تحقق من الكنية	لتأكيد تقديم الدواء للمريض الصحيح		
٩	اغسل يديك	يمنع انتقال العدوى و التلوث		
١٠	ساعد المريض في اتخاذ الوضعية المناسبة	لاعطاء الدواء بشكل امن		
١١	اشرح الهدف لكل دواء للمريض و اسمح للمريض بأي سؤال حول الدواء	من حق المريض أن يعرف (يعلم) و يفهم الهدف و الفائدة من كل دواء يعزز الثقة و المطاوعة بالمعالجة الدوائية		
طريقة إعطاء الدواء				
	الخطوات	التبرير	S تم	U لم يتم
١٢	ربما يرغب المريض بالإمساك بكأس الدواء قبل سكبهِ في فمه	يصبح المريض منسجما و متعاوناً مع أخذ الدواء عن طريق رؤية كل دواء		
١٣	وفر الماء أو العصير للمساعدة في أخذ الدواء	اختيار السوائل يعزز راحة المريض و يحسن أخذ السوائل		
١٤	إعطاء الدواء تحت اللسان: اجعل المريض أن يضع الدواء تحت اللسان و اسمح له أن يذوبها بشكل كامل. و حذر المريض من بلع الكبسولة	الدواء يمتص من خلال الأوعية الدموية تحت اللسان ، إذا بلعت ، سوف يتلف الدواء بواسطة العصارة المعدية أو يزال أثره من قبل الكبد.		

		الأدوية الشدقية تعمل موضعياً على الغشاء المخاطي أو جهازياً كما لو أنها ابتلعت مع اللعاب، عندما تحضر بهذه الطريقة فإن الأدوية المسحوقة تصبح أسماك و حتى أقسى مما يجعل بلعها أصعب الدواء يعمل من خلال الامتصاص البطني من خلال الأغشية المخاطية للفم و ليس الأغشية المخاطية للمعدة المساحيق الفوارة تساعد في تحسين الطعم الغير مرغوب للدواء وحتى أنها تملك قيمة علاجية للمشاكل في السبل الهضمية (المعدة و الأمعاء).	إعطاء الأدوية الشدقية: اجعل المريض أن يضع الدواء في الفم على الأغشية المخاطية الداخلية للوجنة حتى تذاب. امزج الأدوية المسحوقة مع السوائل بجانب السرير و أعطاها للمريض ليشرها. حذر المريض من أن يمضغ أو يبلع أقراص المص. أعطي المساحيق الفوارة و الكبسولات مباشرة بعد إذابتها.	
١٥		لمنع تلوث الدواء. تقديم حبة بشكل منفرد أو كبسولة أسهل للبلع و يمنع الاستنشاق (الشرقة).	إذا كان المريض لا يستطيع أن يمسك الدواء ضع كأس الدواء على شفاه المريض و بشكل لطيف قدم كل دواء في الفم كل واحد لوحده ، لا تسرع.	
١٦		الدواء يصبح ملوث عندما يلامس الأرض	إذا سقطت الحبة أو الكبسولة على الأرض فجأة ، تخلص منها بالطريقة المناسبة.	
١٧		تأخذ الممرضة على عاتقها مسؤولية أن المريض تلقى (أخذ) الدواء الموصوف. إذا ترك بدون انتباه ، المريض يمكن ألا يأخذ الجرعة أو يضعه جانباً، مسبباً أذى للصحة.	ابق حتى ينتهي المريض من تناول كل الدواء.	
١٨		لجعل المريض مرتاحاً	ساعد المريض لأخذ الوضعية المناسبة	
١٩		لجعل بيئة المريض مرتبة و أنيقة و يمنع انتقال العدوى	أعد الأدوات إلى مكان ترتيبها	
٢٠		لمنع انتقال العدوى	غسل اليدين	
٢١		التوثيق الوفي يمنع إعطاء الدواء الخطأ مستقبلياً	وثق في سجل الأدوية وملف المريض مايلي: اسم المريض – اسم الدواء – طريقة الاعطاء – الجرعة والتكرار – التاريخ والوقت – اسم الممرض وتوقيعه – استجابة المريض والملاحظات التمريضية	
٢٢		لمراقبة استجابات المريض للمعالجة	قوم بتأثير الدواء بعد ٣٠ دقيقة. لكل التأثيرات المرغوبة أو الآثار الجانبية.	

*S:Satisfactory- U:unsatisfactory

الأدوية المعوية ، المغطاة، الشدقية، أو تحت

** أعلم الصيدلاني قبل سحق الحبوب أو الكبسولات.

اللسان يجب ألا تسحق.

تعليق المدرس : يؤدي في مختبر المهارات أو على المريض أو ضمن المجتمع سجل عدد المحاولات التي قام بها الطالب قبل الوصول إلى انجاز جيد للمهارة

التاريخ: / / ٢٠٠٩

اسم المدرس:

تطبيق الأدوية الموضعية (Topical Medication) (١) (تطبيق القطرات العينية- الأذنية- الأنفية)

الأهداف (purpose):

أ- القطرات العينية :

- ١- لمعالجة الاضطرابات العينية موضعياً.
- ٢- لتوسيع الحدقة كما الوضع الفعلي أو لتوضيح الرؤية للحدقة.
- ٣- لتنظيف العيون من المفرزات الزائدة للتحضير للعمل الجراحي.

ب- القطرات الأذنية:

- ١- لتليين المفرزات الأذنية.
- ٢- لتقليل الالتهاب و / أو القضاء على الميكروبات.
- ٣- لتخفيف الألم.

ج - القطرات الأنفية:

- ١- لإنقاص تورم الأغشية المخاطية.
- ٢- لحل المفرزات و تسهيل تصريفها.
- ٣- لمعالجة التهاب الجيوب الأنفية .

الأدوات: (Equipment)

١. عربة الأدوية.
٢. ملف المريض و سجل الأدوية .
٣. صينية الأدوية
٤. بيل كهربائي.
٥. الأدوية الموصوفة.
٦. واقي عيني / قماش مخصص للعين.
٧. قطن / محارم ورقية.
٨. قطن ملفوف بشكل مدبب.
٩. منشفة المريض.
١٠. قلم (أسود).
١١. قفازات نبوذة

الإجراء:

أ - تطبيق القطرات العينية:

U لم يتم	S تم	التبرير	الخطوات
		للتأكد من أن الدواء سوف يعطى بأمان و بدقة	١ التأكد من تعليمات الطبيب من ملف المريض ومقارنتها مع سجل الأدوية .
		لتقليل انتقال العدوى من الأيدي إلى الدواء	٢ غسل اليدين
		ترتيب مكان العمل يوفر الوقت و يقلل الخطأ	٣ رتب عربة الأدوية و صينية الأدوية
		خلال فحص و تدقيق اللاصقة للأدوية الموصوفة يقلل الخطأ	٤ اختر الأدوية المطلوبة من صندوق المريض و دققها بالتأكد من ملف المريض :- ١- اسم المريض و رقمه الطبي. ٢- السرير. ٣- الدواء، الجرعة المطلوبة و طريق إعطائها. ٤- تاريخ الصلاحية و انتهائها.
		للامان ، فساد أو انتهاء مفعول الدواء يمكن أن يكون أقل فعالية و يسبب الضرر.	٥ دقق من أجل تاريخ الانتهاء و أي تغير في اللون والقوام.

٦	احسب الجرعة	لضمان سلامة المريض و إعطاء الجرعة بشكل صحيح
٧	خذ صينية الأدوية جانب سرير المريض المحدد	
٨	تعرف على المريض من خلال: • دقق في الشريط الموجود على معصم المريض و الرقم الطبي. • اطلب من المريض أن يؤكد اسمه. • تحقق من كنية المريض.	لتأكيد تقديم الدواء للمريض الصحيح
٩	اشرح الإجراء للمريض.	لتقليل قلق المريض
١٠	أسدل الستائر أو أغلق الأبواب.	للحفاظ على خصوصية المريض
١١	البس القفازات.	لتقليل من انتقال الميكروبات.
١٢	اطلب من المريض أن يستلقي على ظهره مع مد الرقبة للخلف (ثني الرقبة للخلف).	توفر مدخل أسهل للعين لتقطير العين بالدواء. أيضا يقلل من تسرب الدواء من خلال القناة العينية الأنفية.
١٣	في حال وجود قشور أو مفرزات على الجفون أو في زاوية العين، أزله بلطف، بلل (رطب) القشور الجافة و الصعبة الإزالة عن طريق تطبيق قطعة قماش رطبة أو قطن فوق العين لعدة دقائق. (دائما امسح من الزاوية إلى الموقى للعين	القشور أو المفرزات تعتبر كملجأ للميكروبات، التبليل (النقع) دائما أسهل للإزالة و يمنع الضغط الذي سوف يطبق على العين. التنظيف من زاوية العين إلى خارج الموقية يمنع دخول الميكروبات داخل القناة الدمعية.
١٤	امسك لفة القطن أو شاشة نظيفة في اليد الغير معتمد عليها تحت جفن العين، و بلطف اضغط بأصابع اليد أو الإبهام فوق عظم الجنة.	القطن أو قطعة القماش يمتص الدواء الساقط من العين. تقنية العرض تحت الملتحمة. سحب على عظم الوجنة يمنع الضغط و الوزمة للجفن و يمنع ملاسة الأصابع للعين
١٥	اطلب من المريض إن ينظر للسقف	هذا الفعل يسحب القرنية الحساسة للأعلى و بعيدا عن الملتحمة و يقلل منعكس إطباق العين
١٦	تطبيق قطرة العين: ١- بواسطة اليد المعتمد عليها ضعها على جبهة المريض ، امسك قطارة الدواء تقريبا ١ إلى ٢ سم (٠,٥ إلى ٠,٧٥ أنش) فوق ملتحمة العين. ٢- اسكب العدد المطلوب من النقاط داخل ملتحمة العين. ٣- إذا أرف المريض عينه أو أغلقها أو سقطت القطرات خارج الحافة، أعد الإجراء. ٤- بواسطة قطعة قماش نظيفة طبق ضغطا بلطف على القناة الدمعية للمريض لمدة ٣٠ إلى ٦٠ ثانية. ٥- بعد تطبيق النقاط اطلب من المريض أن يغلق العين بلطف ولكن بدون أن يعصرها. تطبيق المراهم العينية: ١- تخلص من الفقاعة الأولى. ٢- اطلب من المريض أن ينظر للأعلى. ٣- طبق المرهم على ملتحمة العين السفلى من الزاوية إلى خارج الموقية. ٤- أغلق عين المريض و مسد (أدلك) بلطف بحركة دائرية بقطعة قطن. ٥- إذا وجد كمية زائدة من الدواء على الجفن ، بلطف امسحها من الزاوية	١-يمنع التماس العرضي للقطارة مع العين، مما يقلل خطر الأذية للعين و يمنع انتقال العدوى إلى القطارة. الأدوية العينية عقيمة ٢-الملتحمة تحتفظ ب ١ إلى ٢ قطرة. تطبيق القطرات على الملتحمة يمنح أيضا توزيع الدواء عبر العين. ٣-المعالجة المؤثرة للدواء يمكن الحصول عليها فقط عندما تدخل القطرات إلى ملتحمة العين ٤-يمنع الكمية من الدواء الطائفة أن تدخل القناة الدمعية . يمنع امتصاصها (انتقالها) إلى الدورة المركزية. ٥-ينشر الدواء فوق كرة العين، العصر يؤدي العين و يدفع الدواء خارجها. ١-يمنع من العدوى. ٢-يقلل منعكس الإطباق عند تطبيق المرهم. ٣-ينشر الدواء بانتظام عبر العين و زاوية الجفن. ٤-يزيد من توزيع الدواء بدون أي أذية للعين. ٥-يزيد الراحة للعين و يمنع الرض عليها.

			إلى خارج الموقى.
١٧	اخلع القفازات	يمنع العدوى	
١٨	أعد فحص الدواء ثانية.	دليل ضد الخطأ	
١٩	إذا كان يملك المريض ضماد للعين، استخدم واحدة نظيفة بتطبيقاتها على العين المتأثرة . ضع الشريط بدون تطبيق ضغط على العين	تنظيف وسادة العين يقلل فرصة العدوى	
٢٠	ساعد المريض لأخذ الوضعية المريحة	يسخن شعور المريض للشفاء	
٢١	اعد الأدوات إلى مكانها	لجعل بيئة المريض مرتبة و أنيقة و يمنع انتقال العدوى	
٢٢	اغسل اليدين	يمنع انتقال العدوى	
٢٣	وثق في سجل الأدوية وملف المريض مايلي: اسم المريض – اسم الدواء – طريقة الاعطاء – الجرعة والتكرار – التاريخ والوقت – اسم الممرض وتوقيعه – استجابة المريض و الملاحظات التمريضية	التوثيق الوتقي يمنع إعطاء الدواء الخطأ مستقبليا	
٢٤	قوم بتأثير الدواء بعد ٣٠ دقيقة. لكل التأثيرات المرغوبة أو الآثار الجانبية.	لمراقبة استجابات المريض للمعالجة	

القطرات الأذنية:

	الخطوات	التبرير	S تم	U لم يتم
١	التأكد من تعليمات الطبيب من ملف المريض وسجل الأدوية.	للتأكد من أن الدواء سوف يعطى بأمان و بدقة		
٢	غسل اليدين	لتقليل انتقال العدوى من الأيدي إلى الدواء		
٣	رتب عربة الأدوية و صينية الأدوية	ترتيب مكان العمل يوفر الوقت و يقلل الخطأ		
٤	اختر الأدوية المطلوبة من صندوق المريض (اقرأ اللاصقة في البداية) و قارنها مع المطلوب و دققها لـ: ٥- اسم المريض و رقمه الطبي. ٦- السرير. ٧- الدواء، الجرعة المطلوبة و طريق إعطائها. ٨- تاريخ الصلاحية و انتهائها.	خلال فحص و تدقيق اللاصقة للأدوية الموصوفة يقلل الخطأ		
٥	دقق من أجل تاريخ الانتهاء و أي تغيير في اللون. التناسق.	للامان ، فساد أو انتهاء مفعول الدواء يمكن أن يكون أقل فعالية و يسبب الضرر.		
٦	احسب الجرعة	لضمان سلامة المريض و إعطاء الجرعة بشكل صحيح		
٧	خذ صينية الأدوية جانب سرير المريض المحدد			
٨	تعرف على المريض من خلال: • دقق في الشريط الموجود على معصم المريض و الرقم الطبي. • اطلب من المريض أن يؤكد اسمه. • تحقق من كنية المريض.	لتأكيد تقديم الدواء للمريض الصحيح		
٩	اشرح الإجراء للمريض.	لتقليل قلق المريض		
١٠	أسدل الستائر أو أغلق الأبواب.	للحفاظ على خصوصية المريض		
١١	البس القفازات.	لتقليل من انتقال الميكروبات.		

١٢	افحص (قيم) بنية قناة السمع بواسطة بيل	لتأمين المعلومات الأساسية . تحدد الاستجابة الموضعية للدواء
١٣	ضع المريض بوضعية الاستلقاء الجانبي مع مراعاة الأذن المراد علاجها للأعلى. أو يمكن أن يجلس المريض على كرسي بجانب السرير	الوضعية توفر محور سهل للأذن لانتشار الدواء
١٤	اجعل القناة السمعية مستقيمة عن طريق سحب الصيوان للأسفل و الخلف (للأطفال) أو للأعلى و الخلف عند (الكبار).	جعل القناة مستقيمة يوفر محور مباشر للبنية الداخلية العميقة للأذن الخارجية.
١٥	في حال وجود صملاخ أو مفرزات أو أي قشور تسد المجرى الخارجي للقناة السمعية، أزلها بلطف بواسطة القطن . لا تضغط على الصملاخ للداخل ليسد أو يغلق القناة.	الصملاخ أو مفرزات تأوي الميكروبات و تسد انتشار الدواء داخل القناة. الانسداد للقناة يتدخل (يقلل) من الحالة الطبيعية للسمع.
١٦	اسكب القطرات الموصوفة مع الإبعاد للقطارة فوق القناة ١ سم .	إدخال القطرات في قناة مغلقة يسبب الأذى لغشاء الطبل
١٧	اطلب من المريض أن يبقى مستلقيا بوضعية الاستلقاء الجانبي لمدة من ٢ الى ٣ دقيقة . طبق مساج خفيف أ ضغط بالإصبع على زئمة الأذن	لضمان توزيع الدواء بشكل كامل. الضغط و المساج يحرك الدواء للداخل.
١٨	١ - ضع قطعة من القطن في الأذن الخارجية على مدخل القناة إذا لزم. ٢- أزل القطن بعد حوالي ١٥ دقيقة.	تحفظ بقاء الدواء عندما ينهض المريض
١٩	ساعد المريض لأخذ الوضعية المريحة بعد تنفيذ الاجراء.	لحفظ الراحة
	اعد الأدوات إلى مكانها	لجعل بيئة المريض مرتبة و أنيقة و يمنع انتقال العدوى
٢٠	غسل اليدين	يمنع انتقال العدوى
٢١	وثق في سجل الأدوية وملف المريض مايلي: اسم المريض - اسم الدواء - طريقة الاعطاء - الجرعة والتكرار - التاريخ والوقت - اسم الممرض وتوقيعه - استجابة المريض والملاحظات التمريضية	التوثيق الوقتي يمنع إعطاء الدواء الخطأ مستقبليا
٢٢	قوم بتأثير الدواء بعد ٣٠ دقيقة. لكل التأثيرات المرغوبة أو الآثار الجانبية.	لمراقبة استجابات المريض للمعالجة

القطرة الأنفية:

م	الخطوات	التبرير	S تم	U لم يتم
١	التأكد من تعليمات الطبيب من ملف المريض وسجل الأدوية.	للتأكد من أن الدواء سوف يعطى بأمان و بدقة		
٢	غسل اليدين	لتقليل انتقال العدوى من الأيدي إلى الدواء		
٣	رتب عربة الأدوية و صينية الأدوية	ترتيب مكان العمل يوفر الوقت و يقلل الخطأ		
٤	اختر الأدوية المطلوبة من صندوق المريض (اقرأ اللاصقة في البداية) و قارنها مع المطلوب في ملف المريض و دققها :- ٩- اسم المريض و رقمه الطبي. ١٠- السرير. ١١- الدواء، الجرعة المطلوبة و طريق إعطائها.	خلال فحص و تدقيق اللاصقة للأدوية الموصوفة يقلل الخطأ		

			١٢- تاريخ الصلاحية و انتهائها.	
٥		للامان ، فساد أو انتهاء مفعول الدواء يمكن أن يكون أقل فعالية و يسبب الضرر.	دقق من أجل تاريخ الانتهاء و أي تغير في اللون و القوام.	
٦		لضمان سلامة المريض و إعطاء الجرعة بشكل صحيح	احسب الجرعة	
٧			خذ صينية الأدوية جانب سرير المريض المحدد	
٨		لتأكيد تقديم الدواء للمريض الصحيح	تعرف على المريض من خلال: • دقق في الشريط الموجود على معصم المريض و الرقم الطبي. • اطلب من المريض أن يؤكد اسمه. • تحقق من كنية المريض.	
٩		لتقليل قلق المريض	اشرح الإجراء للمريض.	
١٠		للحفاظ على خصوصية المريض	أسدل الستائر أو أغلق الأبواب.	
١١		لتقليل العدوى	البس القفازات	
١٢		لإزالة المخاط و المفرزات التي يمكن أن تسد انتشار الدواء	شجع المريض لتنظيف أو نثر الأنف ما لم يكن هناك مضاد استطباب.	
١٣		توفير سبيل أسهل للسبيل الأنفي	تقديم القطرات الأنفية: ١- ساعد المريض لأخذ وضعية الاستلقاء على الظهر. ٢- ضع الرأس وفقا ل: الانحناء الخلفي – أمل رأس المريض للخلف. الجيب الغربالي أو الوتدي – أمل الرأس للخلف فوق حافة السرير أو ضع مخدة صغيرة تحت أكتاف المريض مع إدارة الرأس للخلف للجانب المراد معالجته الجيب الجبهي و الفكي - – أمل الرأس للخلف فوق حافة السرير أو مخدة تحت الرأس مدار إلى الجهة المطلوبة	
			اسكب القطرات الموصوفة مع الإبعاد للقطارة داخل الفوهة الأنفية .	
١٥		لتخفيف الألم	ساعد المريض لأخذ الوضعية المريحة.	
١٦		للحفاظ على رتابة و نظافة بيئة المريض.	تخلص من الأدوات الملوثة	
١٧		يمنع انتقال العدوى	اغسل اليدين	
١٩		التوثيق الوقتي يمنع إعطاء الدواء الخطأ مستقبليا	وثق في سجل الأدوية وملف المريض مايلي: اسم المريض – اسم الدواء – طريقة الإعطاء – الجرعة والتكرار – التاريخ والوقت – اسم الممرض وتوقيعه – استجابة المريض والملاحظات التمريضية	
٢٠		لمراقبة استجابات المريض للمعالجة	قوم بتأثير الدواء بعد ٣٠ دقيقة. لكل التأثيرات المرغوبة أو الآثار الجانبية.	

تعليق المدرس : يؤدي في مختبر المهارات أو على المريض أو ضمن المجتمع

*S:satisfactory- U:unsatisfactory

سجل عدد المحاولات التي قام بها الطالب قبل الوصول إلى انجاز جيد للمهارة

التاريخ: / / ٢٠٢٤

اسم المدرس: